

Il y a tout ce développement qui se fait sur le plan du développement du cortex, tout le développement au niveau du cœur, tout le développement au niveau de tes poumons, tout le développement au niveau de ton foie pancréas digestif, et puis tout le déroulement du tube endodermique. Et finalement, il y a une espèce de magie qui s'interfère. C'est des phénomènes de colocalisation et de synchronicité durant le processus morphogénétique. C'est la réintégration de tout ce système, mais dans un timing spécifique. Tu vois, le 28e jour, on a la fermeture du tube neural. En même temps, j'ai déjà la terminisation d'un looping au niveau du cœur, j'ai déjà une information plus importante au niveau de mes poumons, et tout ça se fait. Donc on va voir que ce qui se passe, par exemple, au niveau du cortex cérébral, dans ces phases de rotation, de déroulement, de croissance, va se faire au même moment au niveau digestif, mais au même moment sur des plans d'appui mésodermiques postérieurs, etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va chercher un maximum d'informations qui peuvent naturellement être un outil thérapeutique. Donc qu'est-ce qui se passe là, et qu'est-ce qui va se passer là ? Qu'est-ce qui se passe là, et qui va se passer ici ? La seule chose que je peux faire, c'est redonner des points d'appui au système. La seule chose, c'est retrouver les fulcrums embryonnaires. C'est de la biodynamique cinétique, mais ça reprend en fait un environnement. Si on regarde la chronologie, il y a une polarité. La polarité permet la mise en place d'une organisation avec à un moment donné l'expression d'un axe notocordal. Cet axe notocordal va donner la mise en place de mon tube neural. Ce tube neural va, dans son développement, redonner la mise en place au niveau du cœur. Le cœur, dans cette phase, vient s'appuyer sur la vésicule viteline qui va créer le diaphragme. Et puis en dessous, il y a un espace, parce que le flot d'informations nutritives arrive, et il y a une phase de congestion. Donc le flot dynamique d'informations, va créer une congestion

sous-diaphragmatique qui est à l'ébauche de l'impulse primitif sur le plan mésodermique dans le mélange endodermique de l'espace de développement d'un foie. Donc le foie, on doit le considérer comme fait de deux grandes structures, l'une purement digestive et l'autre purement mésodermique. Et la rencontre de ces deux va donner un espace sous-diaphragmatique qui prend une grande ampleur parce qu'elle est complètement reliée d'abord au produit de dissimulation de l'ensemble de l'embryon. Le foie est un produit de la désassimilation. Il se développe par les exudats, presque par les déchets, entre guillemets, de l'ensemble du corps. Et puis après, il reçoit l'information ombilicale, ophalomésentérique, où il va commencer à prendre un autre espace. C'est pour ça qu'il est relié à la fois au système vitelin, au système ombilical, et puis il va avoir tout un mélange. Il va se développer, qui fait qu'à un moment donné, donné par la latéralité de l'embryon, il va se développer, il va créer un espace de développement, ce mouvement de développement vers la droite, qui va réorganiser complètement l'espace intra-péritoneal. Toute cette phase de développement duodénal, c'est une phase de rotation, c'est une phase d'organisation pour le cadre duodéno-intestin-grêle-écolique. Et là, on va le voir maintenant dans l'idée du cadre colique, en rapport avec le duodénum.